



ID:B15

Aspects clinico-métaboliques et approche nutritionnelle chez les femmes atteintes du Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

CHIKHAOUI Fatima Zohra⁽¹⁾, HADJARI Mohammed ⁽²⁾, ZOGHLAMI Mourad⁽³⁾

Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Biologiques et la Géomatique LRSBG, Department of Biology, Faculty of Sciences of Nature And Life, Mustapha Stambouli University, Mascara 29000, Algeria.



Abstract

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), récemment renommé syndrome ovarien métabolique polyendocrinien (PMOS) à la suite d'un processus de consensus mondial [1], est un trouble endocrinien fréquent chez les femmes en âge de procréer, touchant 5 à 18 % d'entre elles. Il se caractérise par : L'hyperandrogénie, L'irrégularité des cycles menstruels, La présence d'ovaires polykystiques

L'hyperinsulinémie et l'obésité exacerbent l'hyperandrogénie, ce qui se manifeste par de l'hirsutisme, de l'acné et une alopécie androgénétique (perte de cheveux de type masculin), tout en augmentant les risques à long terme d'infertilité et de diabète de type 2 [2].

Malgré le rôle critique du mode de vie et des habitudes alimentaires, les données nutritionnelles sur les populations d'Afrique du Nord — une région marquée par une forte prévalence de l'infertilité — restent extrêmement limitées et hétérogènes.

Cette étude vise à examiner la relation entre l'IMC, les habitudes alimentaires et les symptômes cliniques du SOPK chez les femmes en âge de procréer dans le Nord-Ouest algérien, en comparant leurs apports en macro et micronutriments à ceux d'un groupe témoin apparié selon l'âge.

Méthodologie

Design de l'étude

Étude cas-témoins appariée selon l'âge (± 2 ans), menée dans des régions sélectionnées du Nord-Ouest algérien (Mascara, Oran et Mostaganem) d'octobre 2025 à mai 2026.

Participants

N = 172 femmes âgées de 18 à 35 ans, recrutées au niveau des consultations de gynécologie à Mascara, Oran et Mostaganem.88 cas de SOPK nouvellement diagnostiqués (critères de Rotterdam)84 témoins sains

Critères d'exclusion

Utilisation de traitements hormonaux au cours des 3 derniers mois

Antécédents d'autres troubles endocriniens (ex. dysfonctionnement thyroïdien)

Suivi d'un régime alimentaire particulier

Sous-déclaration ou sur-déclaration de l'apport énergétique (< 500 ou > 3500 kcal/jour)

Anthropométrie

Mesure standardisée de la taille et du poids pour calculer l'Indice de Masse Corporelle (IMC), classé selon les critères de l'OMS.

Évaluation nutritionnelle

Un journal alimentaire de 7 jours (7DD) a été utilisé pour enregistrer les marques alimentaires ainsi que la taille précise des portions pour chaque repas. La composition nutritionnelle a été analysée sur Microsoft Excel 2019 à partir de la base de données de composition des aliments de l'ANSES.

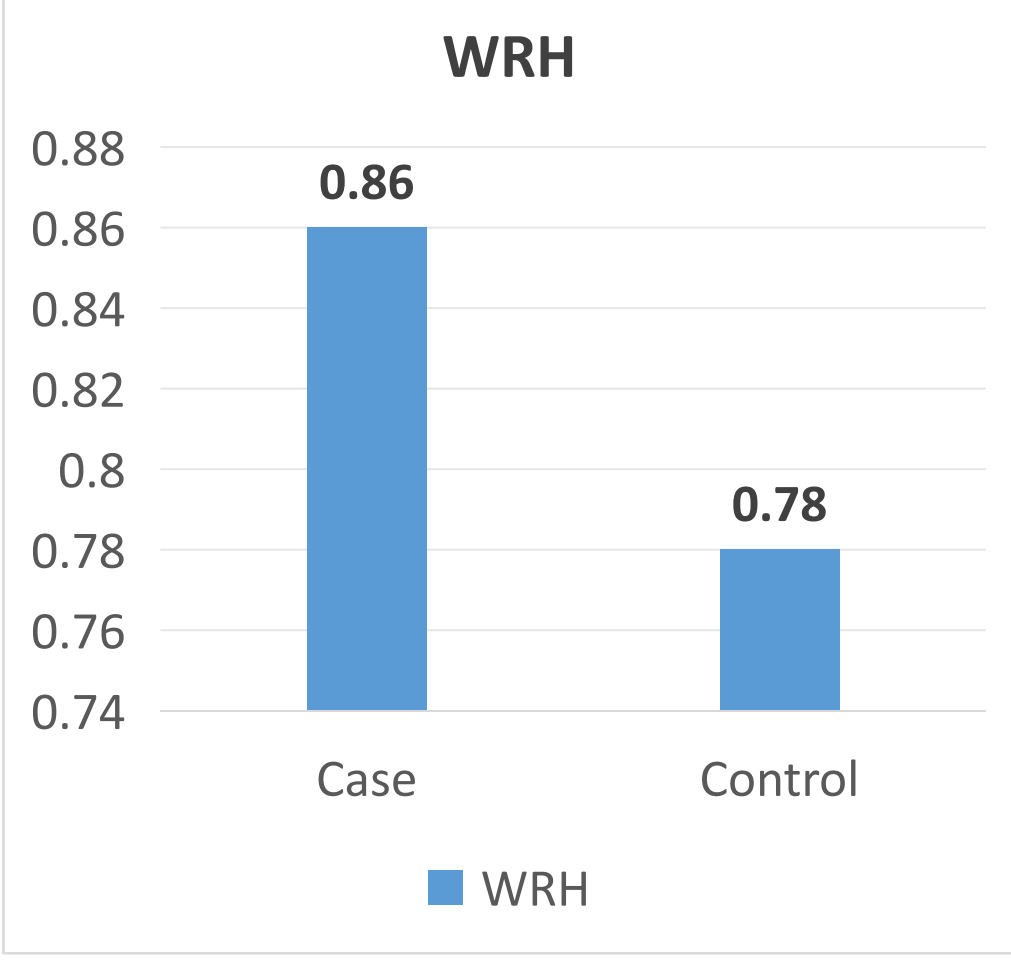
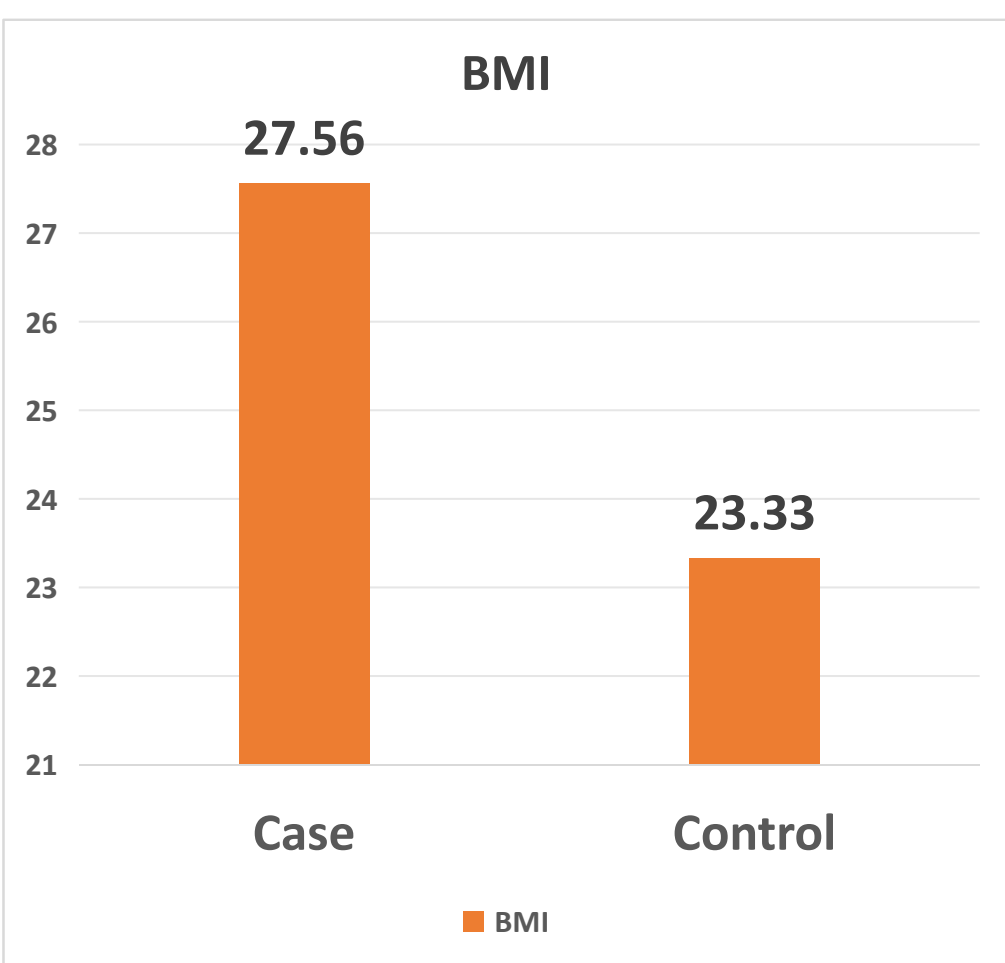
Analyse statistique

Données analysées via le logiciel SPSS versión 27.0. Les variables quantitatives sont exprimées en Moyenne $\pm$ Écart-type (SD). Les comparaisons entre les groupes ont été effectuées à l'aide du test t de Student pour échantillons indépendants ($p < 0,05$).

Résultats

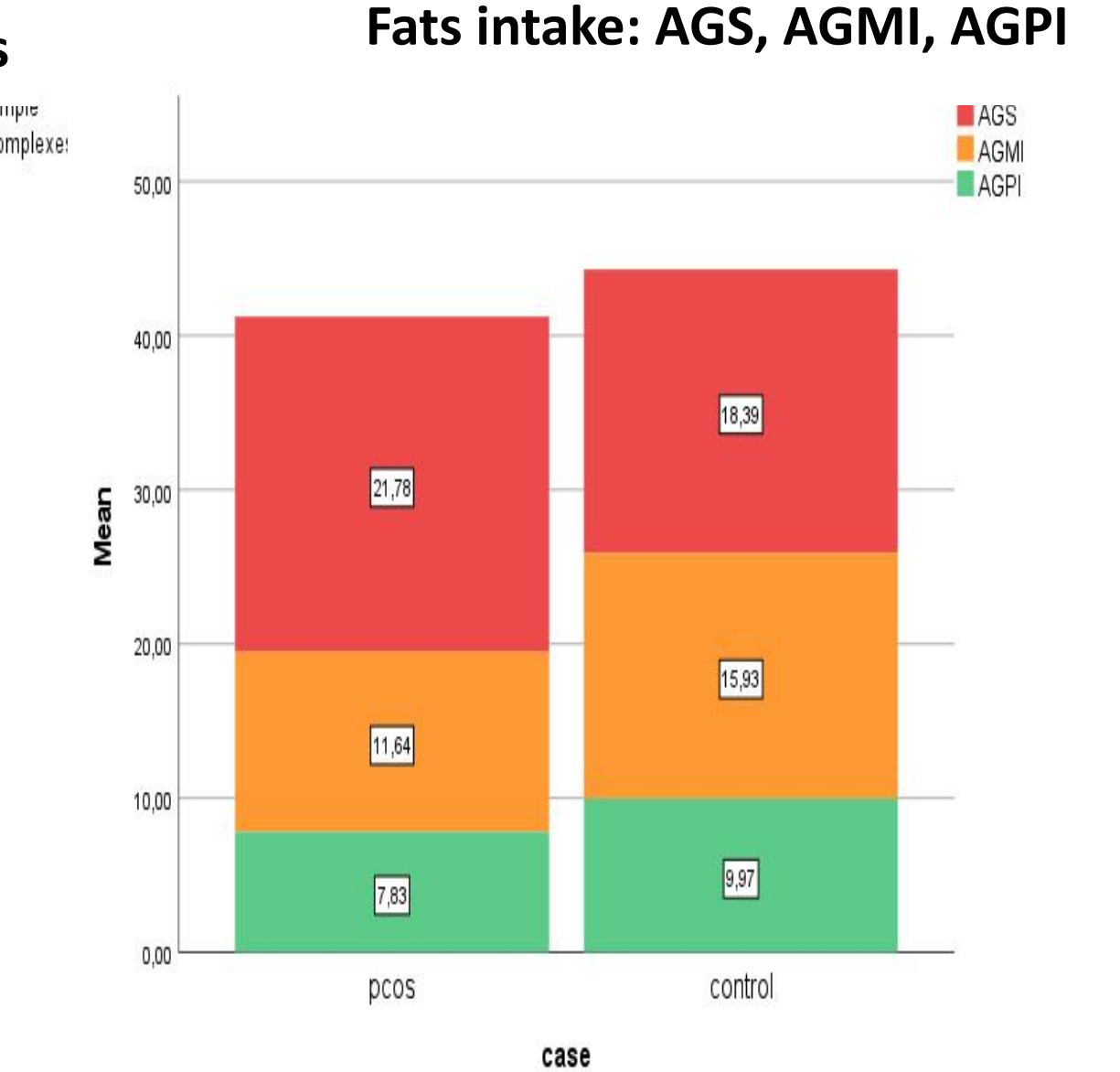
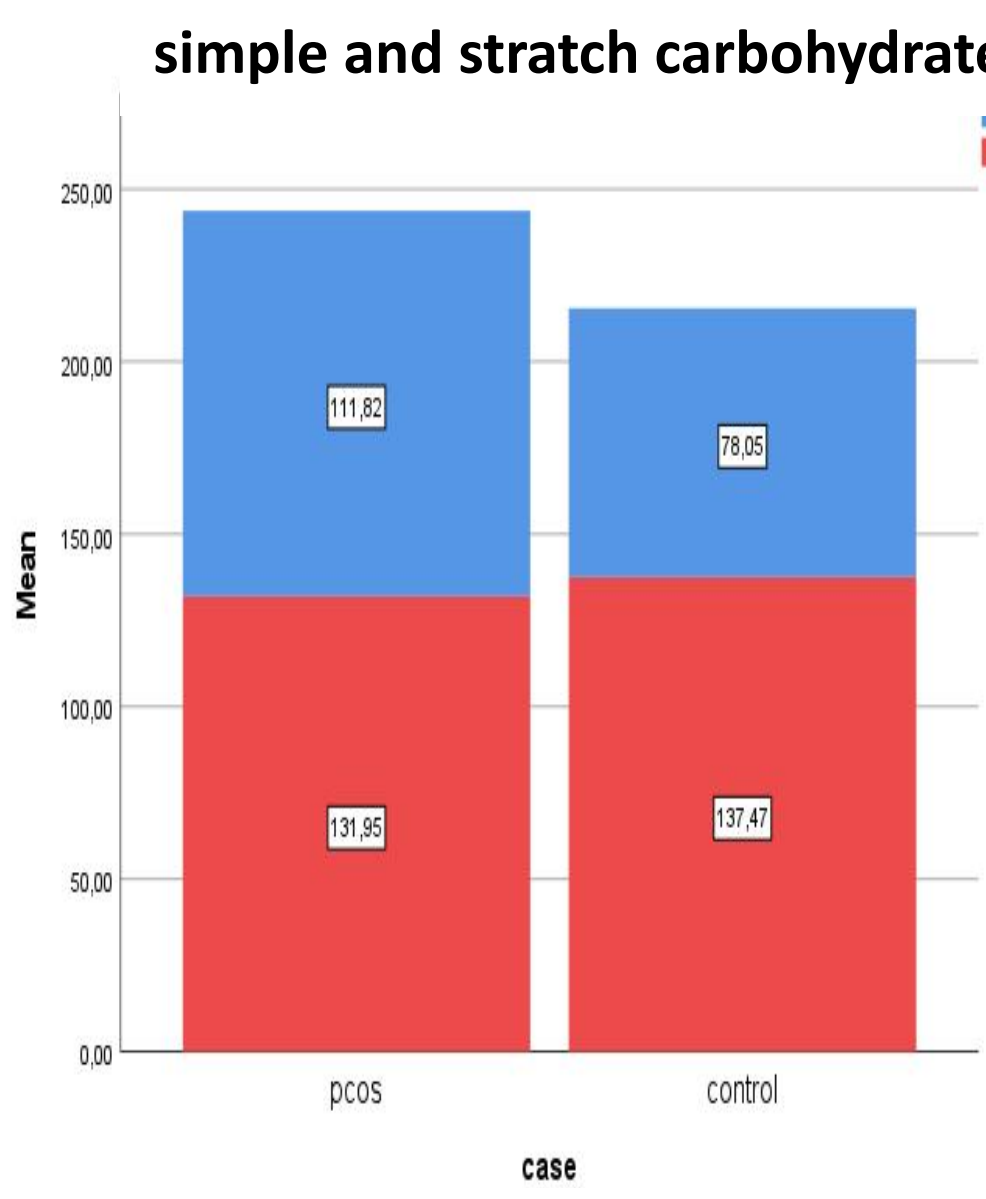
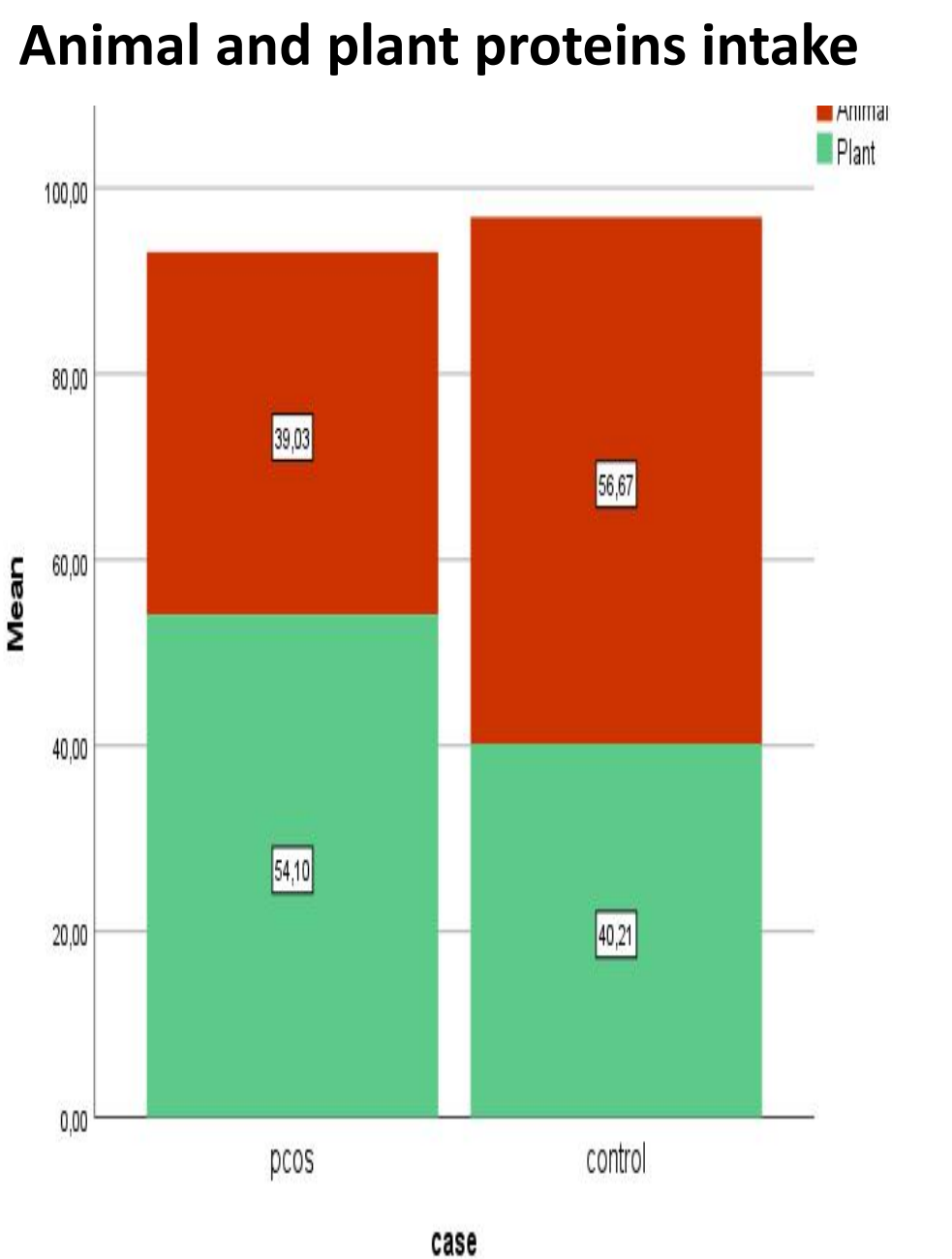
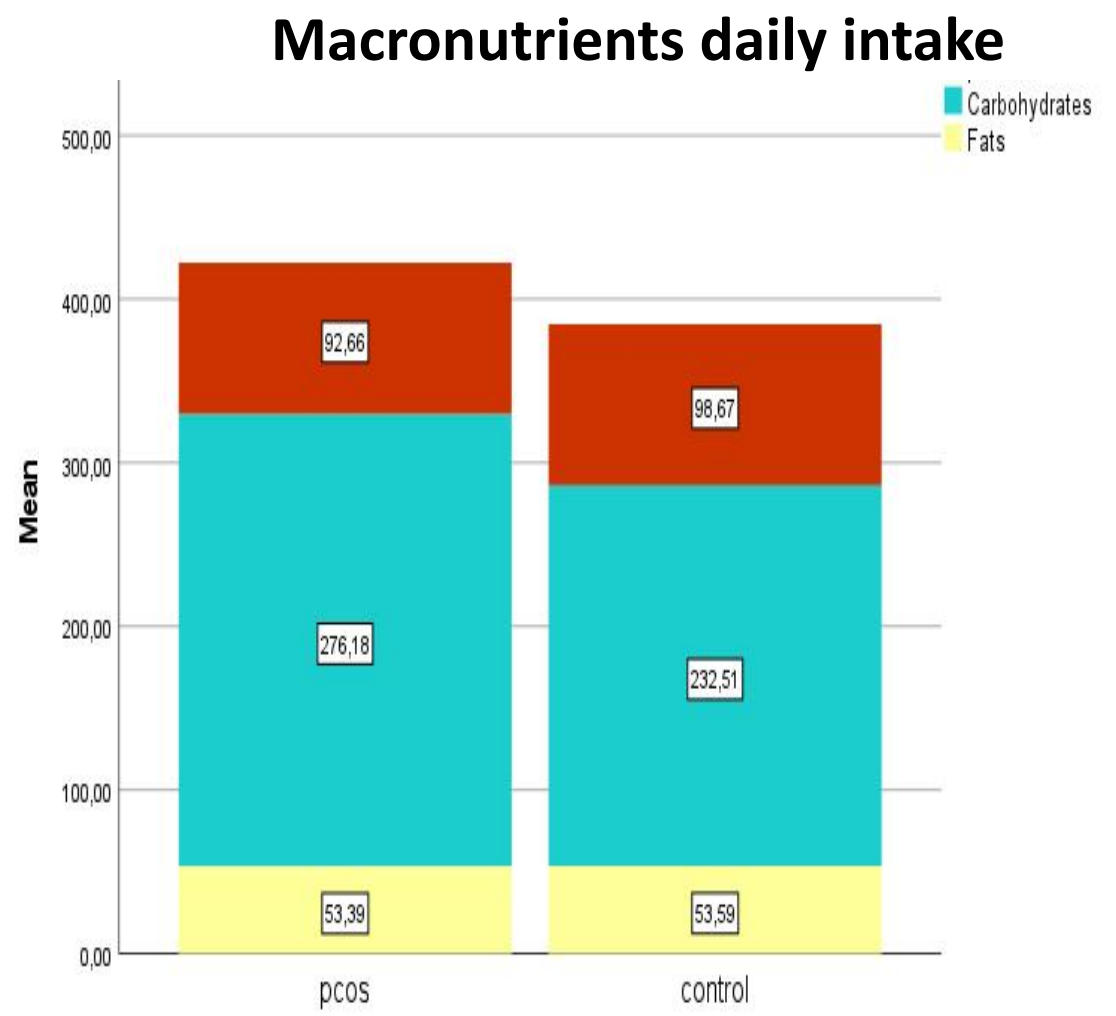
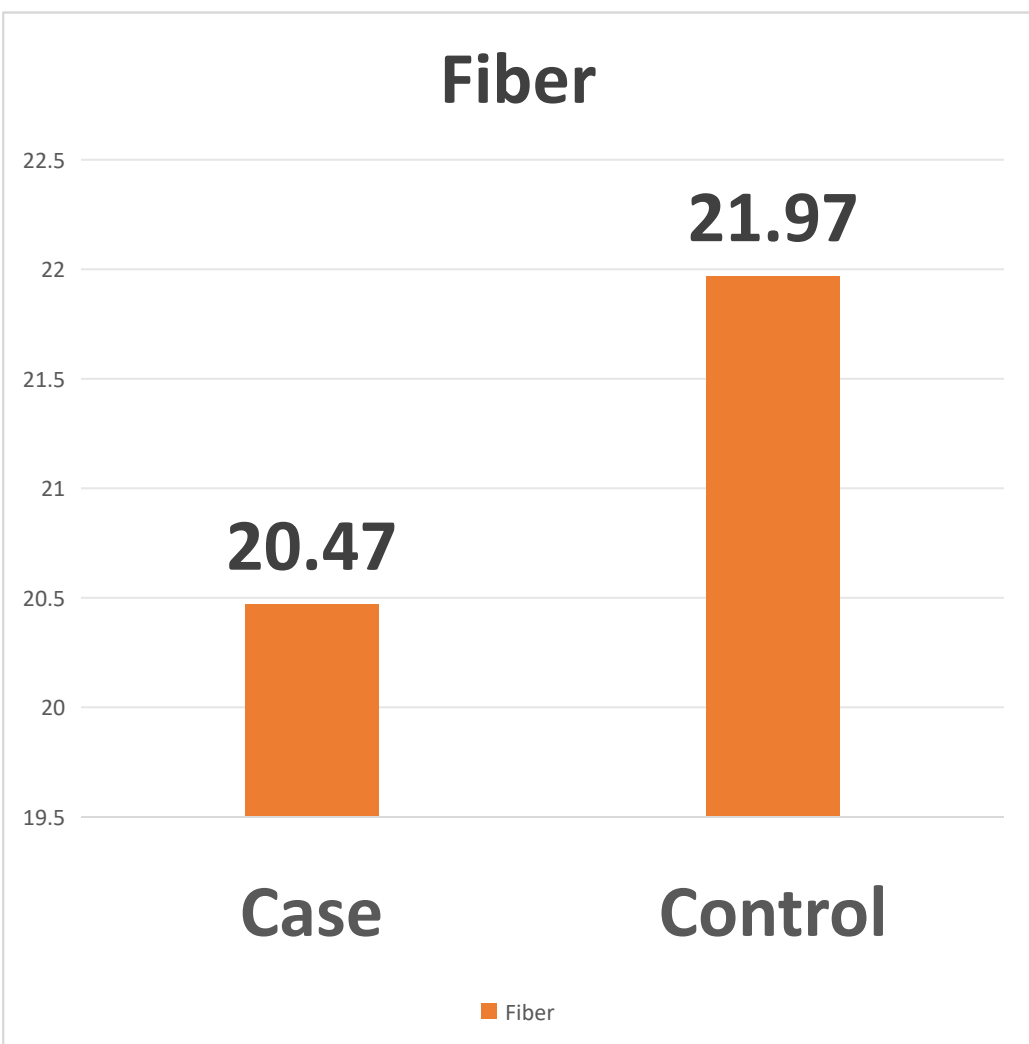
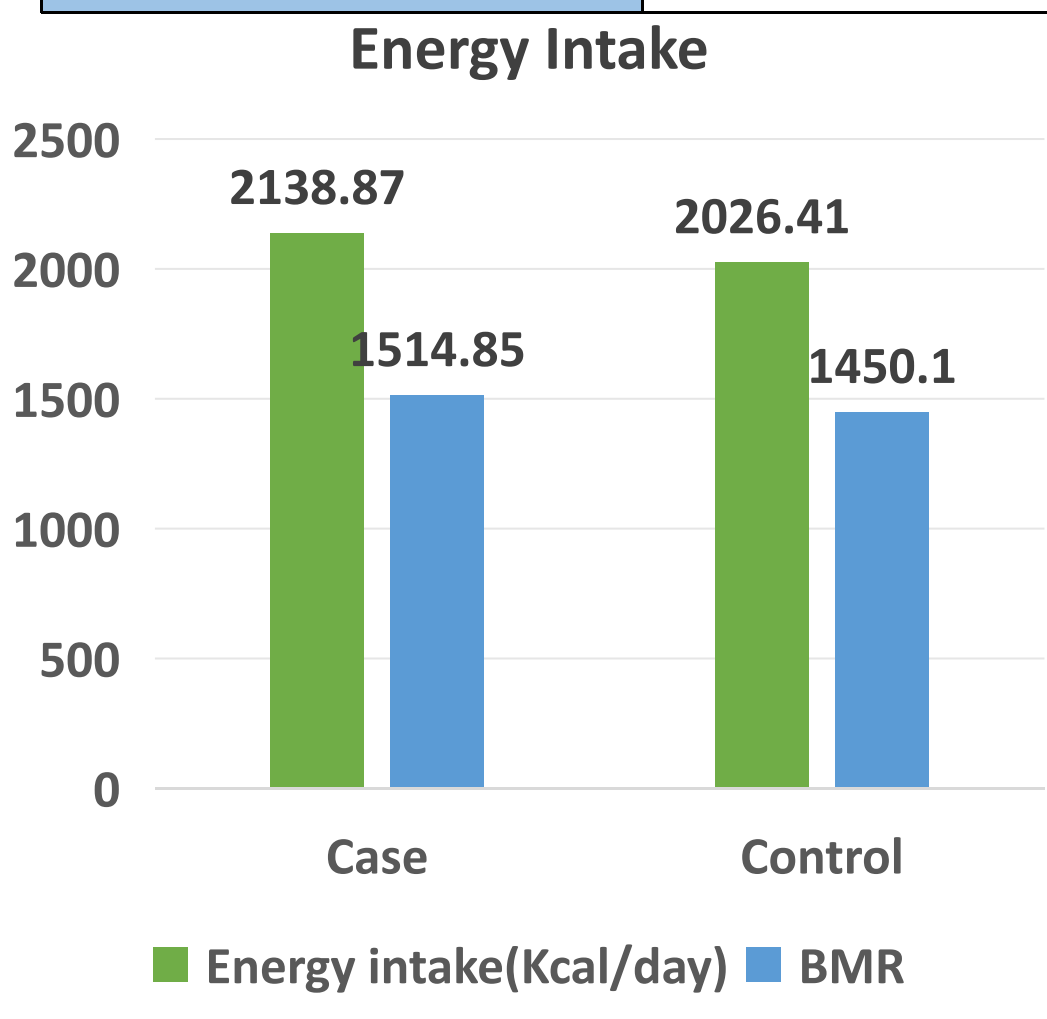
Paramètres anthropométriques

	Cas	Témoins	P-value
Age (ans)	25.68 $\pm$ 4.59	23.33 $\pm$ 4.63	0.845
poids(kg)	73.80 $\pm$ 16.94	64.67 $\pm$ 10.54	0.002
taille(m)	1.63 $\pm$ 0.63	1.65 $\pm$ 0.046	0.130
MB	1514.85 $\pm$ 163.20	1540.1 $\pm$ 108.62	0.007



Les résultats indiquent une variation significative du poids et de l'IMC entre les cas de SOPK et les groupes témoins ($< 0,05$), liée à une forte incidence d'hirsutisme (75.6%) et de dysrégulations menstruelles (80.2%). L'analyse nutritionnelle montre une consommation faible de fibres chez les cas.

	Trouble menstruel	Alopécie	Acné	Hirsutisme
Cas	80.2%	63.2%	60.8%	75.6%
Témoins	19.8%	36.8%	39.2%	24.4%



Conclusion

Cette étude confirme l'association étroite entre le surpoids, les altérations métaboliques et la sévérité des symptômes cliniques du SOPK/PMOS chez les femmes du Nord-Ouest algérien. Les déséquilibres nutritionnels observés, notamment le faible apport en fibres, soulignent l'importance d'intégrer une prise en charge diététique personnalisée dans le protocole thérapeutique de ces patientes.

Références

[1] Teede, H. J., Khomami, M. B., Morman, R., Laven, J. S., Joham, A. E., Costello, M. F., ... & Piltonen, T. (2026). Polyendocrine metabolic ovarian syndrome, the new name for polycystic ovary syndrome: a multistep global consensus process. The Lancet.

[2] Sana Siddiqui, Somaiya Mateen, Rizwan Ahmad, and Shagufta Moin. A brief insight into the etiology, genetics, and immunology of polycystic ovarian syndrome (pcos). Journal of assisted reproduction and genetics, 39(11) :24392473, 2022